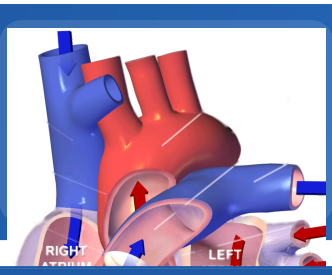
יתר לחץ דם

לחץ הדם וויסותו · הגדרה, גורמים ואיברי מטרה · מצבי חירום, תרופות הבית והאוגדן

דף סיכום · פודקאסטים קלוד



מהו יתר לחץ דם?

ממה בנוי לחץ הדם?

תפוקת הלב × התנגדות הפריפרית. סיסטולי: בכיווץ חדר שמאל. דיאסטולי: כשהלב נח ומתמלא. ויסות: מערכת סימפתטית, נתרן ומים בכליות, בארורצפטורים בקשת האאורטה ובקרוטיד, ADH ורנין־אנגיוטנסין־אלדוסטרון.

מתי זה יתר לחץ דם כרוני?

סיסטולי **מעל 140** או דיאסטולי **מעל 90**, בלפחות **3 מפגשים** (שבוע ביניהם), 3 מדידות בכל מפגש. **במפגש אחד באמבולנס לא מאבחנים.**

119	140–159	160–179	180
ומטה: מיטבי	דרגה 1	דרגה 2	ומעלה: דרגה 3

ראשוני או שניוני?

ראשוני (כ-90%): אין מחלה מוגדרת; אורח חיים, השמנה, עישון, מלח, סוכרת, גיל. **שניוני (כ-10%):** סימפטום של מחלה: קושינג, פאוכרומוציטומה, בלוטת התריס, גלולות, קוקאין, **והכליה** (רנין ← מעגל קסמים).

בשטח: מדוד נכון: שוכב או יושב, לא זז ולא מדבר, יד מתחת לגובה הלב, שרוול מתאים. **מדומה:** עורקים מסוידים ← ניסיונות כושלים וערך גבוה; מדוד בפרק כף היד או בשוק. **חלוק לבן:** הלחץ עולה מול הצוות.

הרוצח השקט: איברי מטרה

זכור: הרוצח השקט: אין סימנים ספציפיים. כשמופיעים תסמינים, לרוב כבר יש פגיעה באיברי המטרה.

מה נפגע?

לב: עיבוי חדר שמאל ← אי ספיקת לב, גודש בריאות. **כלי דם:** דיסקציה, מפרצות, קרע פלאק. **מוח:** איסכמיה, דימום. **עיניים:** היפרדות רשתית, גלאוקומה ← עיוורון. **כליות:** חלבון בשתן ← אי ספיקה.

בשטח: מתי מטפלים?

מצב דחוף

קפיצת לחץ לא מוסברת + תסמינים. להוריד בתוך 24 שעות. חפש גורם: הפסקת תרופות, סטרס, NSAIDs.

מצב חירום

לחץ גבוה + פגיעה חריפה באיבר: שבץ, אנצפלופתיה, בצקת ריאות, ACS, רעלת הריון, דיסקציה.

שימו לב: לא מורידים יותר מ-**30%**: הורדה מהירה פוגעת באספקת הדם למוח, ללב ולכליות.

מד"א: אין פרוטוקול ייעודי

1. **שבץ:** לבטלול שקול (📞) מעל 220/140, או מעל 185/110 במועמד לטרומבוליזה. יעד 180/100
2. **רעלת הריון, בלי פרכוס:** שקול לבטלול (📞) מעל 160/110 ומגנזיום (📞). **עם פרכוס:** תן מגנזיום
3. **לבטלול:** 20 mg לאט בוריד, כל 5–10 דק', עד 300 mg. לא בדופק מתחת ל-60, חסם דרגה +2, אסתמה קשה
4. **אחרת:** פרוטוקול המצב, בהתייעצות עם המוקד

בשטח: תרופות הבית: ריבוי תרופות = לרוב דרגה גבוהה. פריל ← שיעול יבש, אנגיואדמה. ניפדיפין ← בצקת בקרסוליים. פוסיד (פורוסמיד) ← אשלגן נמוך.

3 דברים לזכור

1. **לחץ גבוה במדידה אחת הוא לא אבחנה: מטפלים רק במצב דחוף או במצב חירום.**
2. **לא להוריד יותר מ-30%: מהר מדי פוגע באספקת הדם למוח.**
3. **לבטלול באוגדן: רק בשבץ וברעלת הריון, ורק אחרי התייעצות עם המוקד.**

מקור: התסריט של הסרטון (מצגת הקורס והאוגדן). הדף חומר לימוד ואינו מהווה תחליף לפרוטוקול מד"א המעודכן. איורים: מקוריים, בסגנון הסרטון. איור הלב (מעובד): Blausen Medical, CC BY 3.0, ויקישיתוף.